

10 - Maladie de Behçet - Pr. Essadouni

De 36 ans, qui admet aux urgences pour des céphalées intenses, maximales le matin au réveil. Ça évolue depuis 48 heures et s'est associé à des nausées, des vomissements. Comme antécédent personnel, il a une flébite du membre inférieur au gauche, il y a cinq ans.

Il présente également une cécité de l'œil droit séculaire d'une vélite. Avec cette ulcération, aussi au valaïre, avec un fond blanc et des images de pseudopholliculite qui sont des pustules amicrobiennes qui ne sont pas centrées par un poil. Vous pratiquez chez ce patient un scanner cérébral sans injection.

Il est normal, il y a une IRM, une angio-IRM encéphalique qui objective un thrombus, dont le sinus latéral gauche, comme vous le voyez sur l'image. Chez ce patient, vous évoquez les étiologies des thromboses veineuses cérébrales, voire des états d'hypercoagulabilité, des étiologies hématologiques telles que les syndromes myeloprolifératifs. Des maladies de système telles que le syndrome des antiphospholipides, la maladie de BSEP et si c'est une femme, bien sûr, les étiologies qui sont prédominantes, qui représentent cinq des étiologies des thromboses veineuses cérébrales.

Ces étiologies hormonales peuvent être soit la grossesse et le péripartum, soit la contraception hormonale ou alors la situation. En général, quand on a une thrombose veineuse cérébrale, souvent on a des facteurs, plusieurs facteurs qui sont intriqués et dans 12,5% des cas. Selon cette étude, on ne trouve pas d'étiologie.

Alors, si on vient à notre patient, il a vraisemblablement une maladie de BSEP parce qu'il a de l'aphthose. Il a des antécédents de cécité sur une uveïte récidivante et la thrombose. Tout ça, avec la région d'endémie qui est le Maroc, le premier diagnostic à évoquer chez ce patient est une maladie de BSEP.

Et là, sur ces diapositives, vous avez les étiologies des thromboses veineuses cérébrales. Alors, quel bilan vous demandez chez ce patient? Alors, chez un patient qui a une thrombose veineuse, bien sûr, on va demander numération formule sanguine à la recherche de signes orientant vers un syndrome myeloprolifératif, tel que par exemple une hyperplasie de la lignée myéloïde. On va demander un temps de céphaline activé avec un anticoagulant lupique héréditaire et les autres bilans en fonction des cas associés.

Chez ce patient, vous avez une étude qui montre que dans la majorité des cas, le pronostic est bon. 79% des patients vont guérir 8% de décès quand même. Et puis, il y a des patients qui vont garder des handicaps sévères ou alors minimes.

Et c'est en fonction de la localisation de la thrombose veineuse. Alors, ceci pour introduire le cours concernant la maladie de BSEP. Il s'agit d'une vascularité systémique caractérisée par l'inflammation de la paroi vasculaire.

Elle touche aussi bien les veines que les artères. C'est aussi une maladie générale caractérisée par un triade très caractéristique associant une aphtose buccale, une aphtose génitale et des manifestations ophtalmologiques à type essentiellement d'uvéïte, qui était la base de la première description de cette affection par le dermatologiste turc Uluşi BESEP. Et c'est une affection qui est caractérisée par une prédisposition génétique type HLA B51, mais aussi d'autres gènes de prédisposition qui étaient découverts fréquemment.

C'est une affection qui est très fréquente au Japon et au Moyen-Orient et la répartition géographique de cette affection. Elle suit ce qu'on appelle ici en rouge la route de la soie. Là où les commerçants cherchaient de la soie du l'extrême-orient et le ramenaient vers la Méditerranée.

Et c'est une affection qui va être très fréquente au Japon et en Turquie. Regardez en Turquie, la prévalence est la plus élevée, les 2 80 370 cas par 100 000 habitants. C'est une affection qui est très rare en Europe et dans les pays scandinaves.

Elle est également rare ou exceptionnelle dans les pays de l'Afrique du Sud et aux Etats. Au plan physiopathologique, en plus de la prédisposition génétique, vous avez des facteurs qui déclenchent la maladie comme une exposition à des infections bactériennes ou virales. Ce qui va entraîner une activation des lymphocytes avec production de cytokines inflammatoires.

Et donc, ceci explique les lésions tissulaires de la maladie de B7. L'atteinte cutano-muqueuse est prédominante pour l'aphtose buccale. Elle existe chez 98% des patients.

L'aphtose génitale chez 60 à 65% des malades. Cette aphtose génitale siège au niveau du scrotum, la vulve et le vagin. En général, elle laisse une cicatrice dépigmentée qui peut être, qui peut faire le diagnostic rétrospectif.

On peut avoir un héritage nouveau, une pseudo folliculite qui est caractérisée par des pustules amicrobiennes qui siège au niveau des pommes, des mains, des plantes, des pieds et des jambes, ainsi qu'une hyper réactivité cutanée aspécifique qu'on appelle le test. Concernant les aphtoses buccaux, elles sont sous forme d'ulcération venticulaire. Peut être ovale ou arrondie, avec des contours qui sont très, très bien limités.

En général, elle évolue vers la cicatrisation ensemble avec elle. Contrairement aux aphtoses génitales, comme on a dit, elles vont garder des cicatrices qui font le diagnostic rétrospectif de la maladie et la pseudo folliculite, ce qui est une pustule amicrobienne qui siège au niveau du tronc et de l'intérieur. L'hyper réactivité cutanée non spécifique, en fait, on ne fait plus ce test pour faire le diagnostic de la maladie de B7.

Mais sachez que les patients qui ont une maladie de B7 ont cette caractéristique, c'est à dire ils réagissent de façon exagérée à une injection, par exemple, alors un prélèvement vénère par une petite réaction locale importante. Alors, les autres lésions peuvent avoir des lésions acnéiformes, un héritage nouveau ou alors des nodules souscutanés. Là, vous avez des

manifestations dermatologiques de la maladie de B7.

Regardez, vous avez des ulcérations au niveau des glands, des grandes lèvres, donc des aphtes qui sont très, très actifs, des aphtes au niveau de la langue, au niveau du scrotum, une lésion de pseudo folliculite au niveau du trou et également au niveau des jambes. Là, vous avez la pseudo folliculite, pustule amicrobienne qui n'est pas par un poil. Et là, vous avez des lésions de l'héritage mouveux.

Donc, il peut faire le diagnostic différentiel avec la thrombose veineuse superficielle. Ça se présente également de cette façon. L'atteinte oculaire est très grave quand ça touche l'UV postérieure et avec un risque de cécité quand le diagnostic n'est pas fait de façon précoce.

Une vascularite rétinienne, l'atteinte des vaisseaux rétiens est aussi caractéristique. On a dit que c'est une vascularite systémique. L'UV est antérieure, donc une iridocyclite et donc elle peut faire cette atteinte lorsqu'elle est postérieure.

Elle peut entraîner la cécité. Et donc, il faut savoir la diagnostic thérapeutique et la traiter. Là, vous avez l'exemple d'une uveïte à hypopion.

Regardez le petit sédiment blanc qui était à la base de la première description faite par B7. Alors, on passe aux manifestations vasculaires. Vous avez la thrombose veineuse, elle est retrouvée dans 30% des cas et peut être profonde.

Elle peut toucher les membres inférieurs, mais aussi les membres supérieurs. La veine cave, il peut s'agir d'un syndrome de but qui arrive avec atteinte des veines suzépathiques. Elle peut être superficielle et ça peut faire le diagnostic différentiel avec un érythème.

Nous, l'atteinte artérielle est retrouvée dans 30% des cas, surtout sous forme d'aneurysme au niveau pulmonaire ou alors au niveau de l'aorte et au niveau cérébral. Et cette atteinte artérielle aneurysmale, elle engage le pronostic vital parce qu'il y a un risque de rupture et de mortalité. Là, vous avez quelques images de thrombose veineuse cérébrale en haut et d'aneurysme pulmonaire sur le scanner thoracique.

L'atteinte articulaire, ça peut être sous forme soit d'arthralgie périphérique de nature inflammatoire. On a des patients qui ont une monoarthrite, des genoux, par exemple, ou alors plusieurs articulations et des patients qui ont une atteinte axielle avec une vraie sacroiliite et qui peuvent faire le diagnostic différentiel avec une spondyloarthropathie. On peut avoir aussi une association maladie de baisser la spondyloarthropathie.

L'atteinte neurologique, il y a deux types d'atteintes neurologiques, l'atteinte neurologique paranchimateuse où on a des patients qui se présentent avec des paralysies, soit des hémiparalysies, des troubles du comportement. Une atteinte médulaire à type de myélite transverse avec une paraparalysie et une atteinte non paranchimateuse qui est caractérisée par l'atteinte vasculaire cérébrale à type de thrombose veineuse cérébrale. Alors, l'IRM est très importante chez ces patients là, parce que même lorsqu'on fait un scanner, on peut passer

aussi bien à côté des lésions vasculaires que des lésions paranchimateuse et son préférentiel de ces lésions paranchimateuse et le thrombose cérébrale.

Alors, l'atteinte digestive peut prêter confusion avec une maladie inflammatoire cryptogénique intestinale et on peut avoir des ulcérations comme les afts qu'on a au niveau de la bouche, avec une autre localisation au niveau de l'œsophage, du crêle, du côlon et avec la biopsie qui montre juste une inflammation non spécifique. C'est pas la localisation. En fait, ce n'est pas la description caractéristique de la maladie de Crohn.

Vous avez quelques images d'ulcérations digestives. Alors là aussi, toutes les tuniques du cœur peuvent être atteintes. La péricardie, on peut avoir une péricardie qui se manifeste par des douleurs typiques de la péricardie.

On peut avoir des atteintes des vaisseaux coronariens se manifestant par des douleurs thoraciques type angineuse, voire à l'infarctus myocarde, une atteinte du muscle péricardique, atteinte du muscle cardiaque avec un tableau d'insuffisance cardiaque, une cardiomyopathie dilatée ou alors une atteinte endocardique avec une endocardite subaiguë ou aiguë. Alors, sur le plan biologique, le syndrome inflammatoire n'est pas indispensable au diagnostic, c'est à dire même en l'absence de syndrome biologique inflammatoire, on ne peut pas éliminer le diagnostic des maladies de BSEP. On peut avoir un syndrome biologique inflammatoire quand on a une atteinte vasculaire, comme une thrombose veineuse, quelle qu'en soit la localisation ou alors des anévrismes pulmonaires.

Et en général, il n'y a pas d'anomalie de la coagulation dépistable chez ces patients là pour expliquer l'atteinte vasculaire. Donc, chez ces patients, on incrimine la vascularité dans la genèse de cette thrombose veineuse et matériel. Le diagnostic repose sur les critères internationaux qui ont été validés en 2013 et ces critères comprennent l'atteinte ophtalmologique, l'aphthose génitale, l'aphthose buccale, les manifestations cutanées, les manifestations neurologiques et les manifestations vasculaires, ainsi que le test.

Alors, chaque atteinte est cotée. Donc, quand on a, par exemple, pour l'atteinte ophtalmologique, vous avez deux points, l'aphthose génitale, deux points. Et si on a quatre points, on peut faire le diagnostic d'une diagnostic.

Le diagnostic différentiel en cas d'aphthose peut se poser avec les aphthose, les ulcérations buccales secondaires à une infection hépatique avec des MICI, maladies chroniques cryptogéniques intestinales. La maladie de la maladie céliaque peut également entraîner des aphthes, l'ulipus systémique peut entraîner aussi des ulcérations buccales et les maladies bulleuses comme la panfigoïde, le panfigus vulcaire et la panfigoïde cicatricielle, ainsi que l'ulicaine. Alors, on peut évoquer chez ces patients la sarcoïdose devant un érythème ou une uveïde, un syndrome de rétère devant les ulcérations orales et génitales et une atteinte des sacroiliac.

Et on peut évoquer également chez ces patients sclérose en plaques quand on a une atteinte

neurologique par enchymateuse prédominante. Sur le plan du pronostic, l'atteinte cutanéomyqueuse, elle est de bon pronostic, mais bon, mais elle est très, très douloureuse et les aphthes génitaux, quand ils sont de grande taille, empêchent le patient de marcher correctement. Les aphthes buccaux empêchent le patient de manger ou de parler correctement.

Elles sont très douloureuses la nuit. Elles ont une caractéristique inflammatoire. Les manifestations ophtalmologiques, lorsque ça touche le segment postérieur ou alors lorsqu'il s'agit d'une vascularie trétinienne, ça peut entraîner la cécité et les manifestations neurologiques et pulmonaires.

Là aussi, ils ont un pronostic vital parce que la névrisme, il peut se rompre et l'atteinte neurologique, par exemple, elle peut entraîner des déficits qui sont permanents avec un individu. Sur le plan thérapeutique comme moyen, on a la colchicine. Alors la colchicine est donnée essentiellement pour l'atteinte cutanéomyqueuse.

Mais c'est un traitement qui a démontré son efficacité dans la prévention des formes graves. Il ne faut pas arrêter ce traitement chez les patients qui ont une maladie B7. Alors, il ne faut pas donner une dose importante.

10 mg, c'est une dose létale. Elle entraîne une myolise et des atteintes cérébrales irréversibles. Alors, comme traitement des manifestations articulaires, on peut avoir recours aux antiinflammatoires non sérologiques, les anticoagulants en cas de thrombose veineuse profonde.

Vous avez les antibodies, les HBPM suivi par les anticoagulants et on a aussi la corticothérapie en cas d'atteinte ophtalmologique et cérébrale. Les immunosuppresseurs, quand vous avez des formes graves comme l'atteinte ophtalmologique, l'atteinte vasculaire à type de thrombose, par exemple, le syndrome, le syndrome de butchery ou alors une thrombose gare et l'atteinte neurologique par enchématoze aussi. On peut avoir recours aussi à l'interférent alpha et aux antitès NF et le talidomide en cas d'atteinte cutanomiqueuse grave qui ne répond pas à la colchicine.

Pour les indications, l'atteinte cutanomiqueuse et articulaire est traitée par la colchicine et les antiinflammatoires non stéroïdiens. L'atteinte vasculaire neurologique et ophtalmologique est traitée par la corticothérapie à forte dose des immunosuppresseurs interférent alpha, voire une biothérapie à type d'antité NF alpha et d'anti interleukin 6.